

Optimización y Priorización de Referencias Bibliográficas

**Guía de Estudio Detallada:
Desde el Marco Teórico hasta la
Medicina Basada en
Evidencias (MBE).**



¿Por qué es fundamental el Marco Teórico?



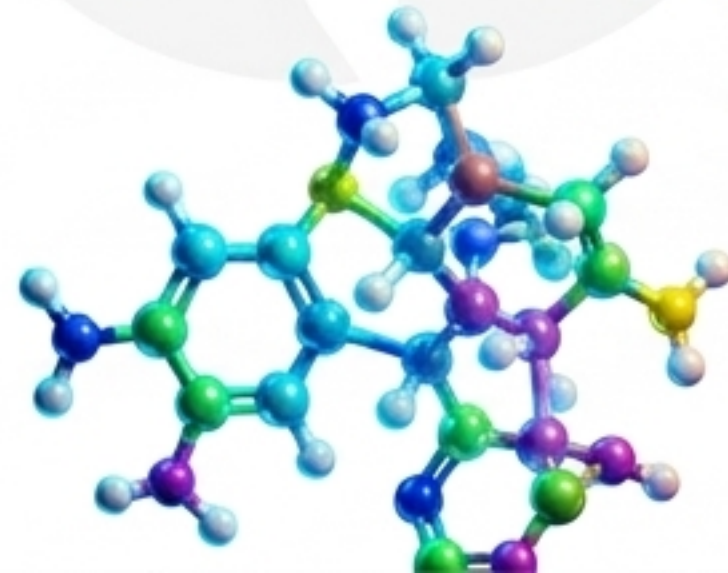
Naturaleza de las Teorías Científicas y Marcos Conceptuales

Origen y Creación

- Las teorías no se descubren, se **crean y desarrollan**.
- Dependen de observaciones empíricas (hechos) y del **ingenio del científico** para integrarlas en un modelo inteligible.
- Permiten describir, comprender y explicar el problema, además de plantear **hipótesis**.

Evolución y Refutabilidad

- Una teoría es simplemente el mejor esfuerzo actual para explicar un fenómeno.
- **Pueden ser comprobadas, pero NUNCA** se consideran definitivas.
- Principio de evolución: La teoría exitosa de hoy puede ser desechada mañana ante nueva evidencia.



Filtro Crítico: Selección de Evidencia Inicial



Calidad y Relevancia: Identificar la importancia de los resúmenes; los estudios de alto impacto deben describirse a detalle.



Panorama General: Mostrar el estado actual del conocimiento (lo que ya se sabe del problema a investigar).



Juicio Crítico: Reflejar una evaluación rigurosa sobre la amplitud y confiabilidad de la información existente.



Justificación: Demostrar por qué es estrictamente necesario el nuevo estudio.



Tematización: Determinar los temas principales y establecer un orden lógico de presentación.



El Desafío Clínico: La Intoxicación Médica



3,000+

Nuevos
artículos (papers)
publicados
por día a nivel
mundial.

1,000+

Nuevos artículos
indexados en
grandes bases
de datos
(MEDLINE)
cada 24 horas.

46+

Estudios
Aleatorizados
Controlados
(RCTs) diarios.

27 Kg

El peso físico
promedio de las
Guías de
Atención Clínica
modernas.

**Es humanamente imposible
asimilar la literatura clínica
mediante la simple lectura
continua.**

Síndrome JASPA y la Carga de Lectura Mínima

Journal: ¿Duda en renovar suscripciones por falta de tiempo?

Anger: ¿Siente ira hacia autores muy prolíficos?

Sleep: ¿Usa las revistas médicas para poder dormir?

Piles: ¿Está rodeado de pilas de publicaciones sin leer?

Anxious: ¿Siente ansiedad cuando llega una nueva revista?

Sumando las principales revistas de una especialidad (ej. Pediatrics, NEJM, Lancet, JAMA, BMJ)...

Se generan **1,694 artículos importantes por año.**

=

= 5 ARTÍCULOS AL DÍA, todos los días del año, solo para mantenerse actualizado.



El Cambio de Paradigma en la Toma de Decisiones

Enfoque TRADICIONAL

1. Identificar el problema empíricamente.
2. Usar nuestra experiencia clínica acumulada.
3. Preguntar a un colega (Basado en Opinión).
4. Consultar un libro de texto (Frecuentemente desactualizado).
5. Leer una revisión narrativa general.



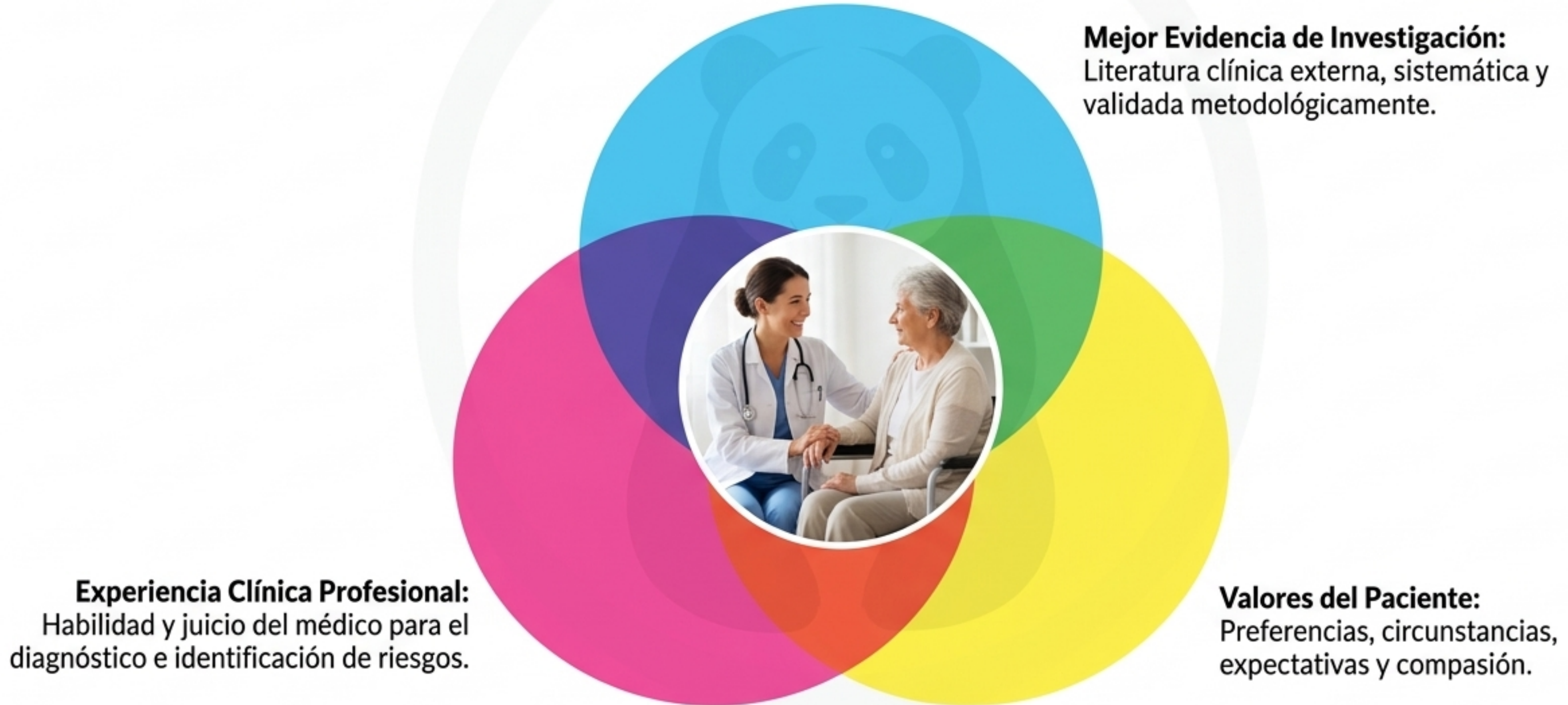
Enfoque ACTUAL (MBE)

1. Formular una pregunta clínica estructurada.
2. Realizar búsqueda sistemática de literatura.
3. Seleccionar los artículos clave más relevantes.
4. Juzgar críticamente los artículos (Validez y Utilidad).
5. Aplicar el resultado científicamente al paciente individual.



Definición de Medicina Basada en Evidencias (MBE)

El uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para tomar decisiones clínicas sobre el cuidado de cada paciente individual.



El Fundamento: Valoración Crítica (Critical Appraisal)

Concepto central que dio origen a la MBE.
Son los métodos rigurosos para valorar clínicamente la calidad de la información publicada, separando la evidencia sólida de los sesgos y opiniones.

GRADO A:

La máxima fortaleza metodológica.
Recomendación clínica sólida.

GRADO B:

Evidencia moderada.
Recomendación favorable.

GRADO C:

Evidencia débil o inconsistente.
Recomendación sugestiva.

GRADO D:

Opinión pura, baja fuerza epidemiológica.
Precaución.



Relación Volumen vs. Validez de Publicaciones



Clasificación de Estudios: Grados A y B (Alta Fortaleza)



Nivel de Recomendación A

- **1a:** Revisión Sistemática (con homogeneidad) de Ensayos Controlados Aleatorizados (RCTs). Reglas de predicción clínica validadas en diferentes poblaciones.
- **1b:** Ensayo Controlado Aleatorizado (RCT) individual con intervalos de confianza estrechos.
- **1c:** Estudios de Todo o nada (All or none).

Nivel de Recomendación B

- **2a:** Revisión Sistemática (con homogeneidad) de Estudios de Cohorte.
- **2b:** Estudio de Cohorte individual o RCT de baja calidad (<80% seguimiento).
- **2c:** Investigación de resultados (Outcomes Research) o Estudios ecológicos.
- **3a:** Revisión Sistemática (homogénea) de estudios de Casos y Controles.
- **3b:** Estudio individual de Casos y Controles.

Clasificación de Estudios: Grados C y D (Baja Fortaleza)



Nivel de Recomendación C

4: Serie de Casos y reportes de casos. (Incluye también estudios de cohorte y de casos/controles de baja calidad metodológica).

Característica de debilidad: Patrón de referencia pobre o no independiente, sin análisis de sensibilidad, estándares de referencia superados.

Nivel de Recomendación D

Característica de debilidad: Valoración crítica expectata.

5: Opinión de expertos sin valoración crítica explícita.

Característica de debilidad: Basado en fisiología básica, investigación de laboratorio en animales (bench research), teorías económicas o primeros principios. Carece de control epidemiológico poblacional sistemático.

El Estándar de Oro: ¿Qué hace una Revisión Sistemática?



Estrategias Prácticas para la Ejecución

Caza de Literatura



Contactar expertos u oradores de conferencias médicas sobre el tema.



Consultar bibliotecarios en universidades o institutos de investigación.



Usar índices rigurosos (Index Medicus), bases de resúmenes (MEDLINE) y rastrear bibliografías cruzadas en artículos clave.

La Ficha Bibliográfica

Flujo: Lea/hojee primero -> Capture metadatos -> Redacte resumen analítico.

Formato Universal

Obligatorio: Autor(es) [apellido + iniciales]. Título del artículo, Nombre de la revista, Año; Volumen: Páginas.

Incorpore información clave inmediatamente para facilitar la recuperación en la fase de escritura.



Domina la Medicina con **BADBEAR.MED**

La evidencia se transforma, la excelencia permanece.
Creado por y para estudiosos de élite.



@BADBEAR.MED



@BADBEAR.MED



BADBEAR.MED



BADBEAR.MED



BADBEAR.MED



t.me/BADBEARMED



@BADBEAR.MED